
Semiologia

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução à Semiologia	3
02 Exame Clínico	5
03 Biossegurança	6
04 Lesões Fundamentais	8
05 Exames de Sangue	11
06 Hipertensão Arterial	13
07 Diabetes Mellitus	14
08 Referências	15

01

CONTEÚDO COMPLETO

Introdução à Semiologia

Semiologia

PONTOS-CHAVE

A semiologia é o estudo dos sinais (observáveis) e sintomas (relatados) das doenças. No contexto da Odontologia, é fundamental para:

- Identificar doenças bucais e sistêmicas em estágios iniciais
- Prevenir complicações e tratamentos incorretos
- Garantir segurança e precisão no atendimento
- Facilitar a comunicação entre profissionais da saúde.

Semiogênese

A semiogênese é o campo que investiga como sinais e sintomas surgem no corpo humano, com base na fisiopatologia.

Permite entender por que uma lesão ou dor ocorre

Ajuda a estabelecer o raciocínio clínico baseado nas causas reais do problema

Essencial para diferenciar doenças com manifestações semelhantes.

Refere-se ao conjunto de técnicas usadas para analisar e interpretar os dados coletados na consulta.

Componentes:

Anamnese – coleta dos sintomas (parte subjetiva).

Exame físico – observação dos sinais (parte objetiva).

Esse processo gera hipóteses diagnósticas, que serão confirmadas por exames complementares.

Sinais e Sintomas

Estrutura do Atendimento Clínico Odontológico

Anamnese

Exame físico

Hipóteses diagnósticas

Exames complementares

Diagnóstico final

Tratamento

Prognóstico

Proservação (acompanhamento)

Semiotécnica

É o conjunto de métodos técnicos e organizados para pesquisar e identificar sinais e sintomas:

Inclui perguntas específicas, observações e manobras clínicas

Visa extrair informações completas e confiáveis

Permite planejar e personalizar o tratamento.

Termo	Definição	Exemplos
Sinais	Evidências objetivas observadas pelo profissional.	Manchas, úlceras, crescimento tecidual
Sintomas	Sensações subjetivas relatadas pelo paciente.	Dor, ardor, cansaço, prurido, disfagia



ANOTAÇÕES

02

CONTEÚDO COMPLETO

Exame Clínico

Divisão:

PONTOS-CHAVE

Envolve tudo o que é realizado na primeira consulta:

Subjetivo (Anamnese): informações dadas pelo paciente.

Objetivo (Exame físico): observações feitas pelo profissional.

A partir disso, gera-se uma hipótese diagnóstica e, com os exames complementares, chega-se ao diagnóstico final.

Metodologia do Exame Clínico

Coleta de informações subjetivas (anamnese)

Coleta de informações objetivas (exame físico)

Perguntas para diagnóstico diferencial

Solicitação de exames complementares

Importância da Anamnese

A anamnese representa cerca de 60% do diagnóstico clínico, seguida por:

30% do exame físico

10% dos exames complementares

Ela envolve:

Primeira impressão

Postura e locomoção do paciente

Estado emocional

Relação com acompanhantes

Acolhimento e empatia



ANOTAÇÕES

03

CONTEÚDO COMPLETO

Biossegurança

Medidas de Controle de Infecção

PONTOS-CHAVE

Assepsia:

Prevenção da entrada de microrganismos no organismo.

Antissepsia:

Uso de produtos sobre pele e mucosa para reduzir microrganismos.

Desinfecção:

Redução de microrganismos em superfícies inanimadas.

Tipos de Erros Clínicos

Erro médico: falha não intencional que causa dano.

Negligência: omissão do que deveria ser feito.

Imprudência: ação feita de maneira irresponsável.

Imperícia: falta de habilidade para executar corretamente.

Iatrogenia: dano causado pelo tratamento.

Físico: ruídos, radiação, vibração, perfurocortantes.

Químico: exposição a produtos como mercúrio e reveladores.

Biológico: contato com vírus, fungos, bactérias.

Ergonômico: má postura, movimentos repetitivos.

Psicossocial: estresse, exaustão, depressão.

Doenças Infectocontagiosas

Hepatites B e C

HIV

Tuberculose

Meningite

Herpes

Gripe

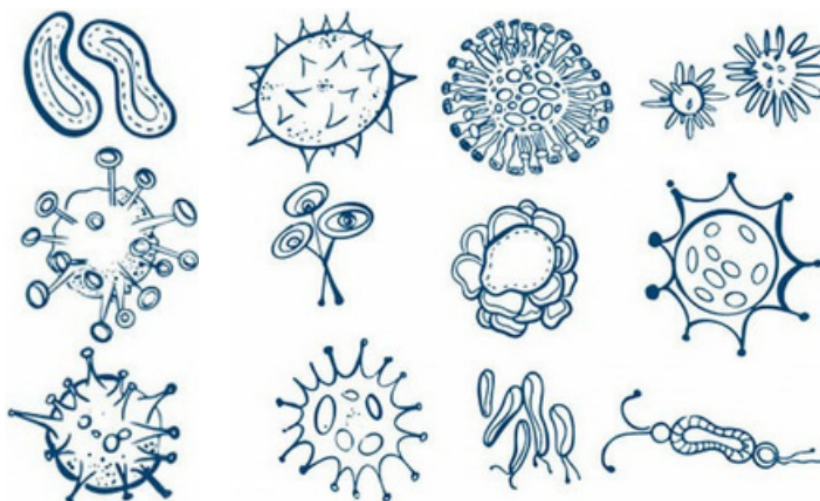
Sífilis

Tipo	Característica	Exemplo
1	Não causam doença	Lactobacilos
2	Podem causar doença leve	Febre amarela
3	Causam doenças graves, mas têm tratamento	COVID-19
4	Doenças graves sem cura ou vacina	Ebola



Contaminação Cruzada

- É a transferência de microrganismos entre instrumentos, superfícies e pessoas. Pode ocorrer por falhas na higiene, uso incorreto de EPI ou esterilização inadequada.



ANOTAÇÕES

04

CONTEÚDO COMPLETO

Lesões Fundamentais

Alterações de cor:

PONTOS-CHAVE

Mácula (mancha): sem elevação.

Enantema: mancha vermelha na mucosa.

Placa: mancha elevada e espessada.

Formações sólidas:

Pápula: < 5mm, bem delimitada.

Nódulo: > 5mm, pode ser séssil ou pediculado.

Coleções líquidas:

Vesícula: < 3mm, conteúdo líquido.

Bolha: > 3mm.

Perda tecidual:

Erosão: superficial, afeta só o epitélio.

Úlcera: profunda, atinge tecido conjuntivo.

Descrição completa da lesão:

Tipo

Localização

Tamanho

Limites

Número

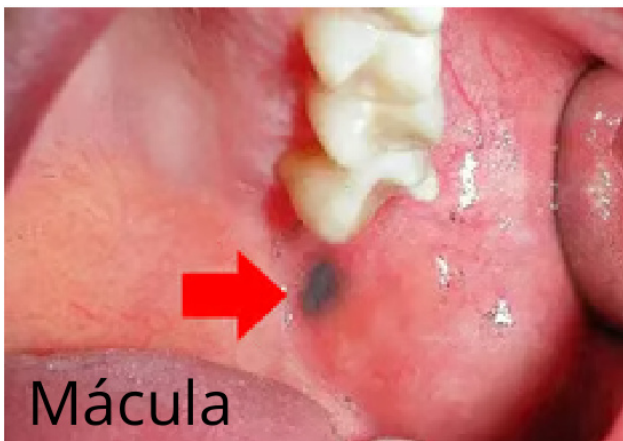
Cor

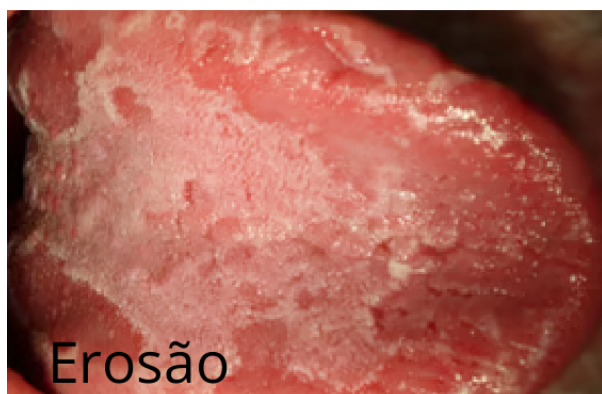
Bordas

Base

Consistência

Superfície







ANOTAÇÕES

05

CONTEÚDO COMPLETO

Exames de Sangue

Hemograma:

PONTOS-CHAVE

Exame que avalia as células sanguíneas e auxilia no diagnóstico de várias condições.

Eritrograma:

Avalia hemácias, hemoglobina e VCM.

Alterações:

Eritrocitose: excesso de hemácias

Eritropenia: diminuição das hemácias

VCM baixo: anemia ferropriva

VCM alto: anemia megaloblástica

Leucograma:

Avalia leucócitos (células de defesa):

Neutrófilos: infecção bacteriana aguda

Linfócitos: infecção viral crônica

Monócitos: processos crônicos e infecciosos

Eosinófilos: alergias e parasitas

Alterações:

Leucocitose: aumento de leucócitos

Leucopenia: queda de leucócitos

Plaquetas:

Responsáveis pela coagulação.

Trombocitose: aumento – resposta inflamatória

Trombocitopenia: queda – risco de sangramento

Sangue:

Transporte de nutrientes e oxigênio

Regulação térmica e osmótica

Defesa imunológica

Coagulação

Hemoglobina:

HCM: quantidade de Hb por hemácia.

CHCM: concentração percentual de Hb.

Valores hematológicos de referência - Série branca

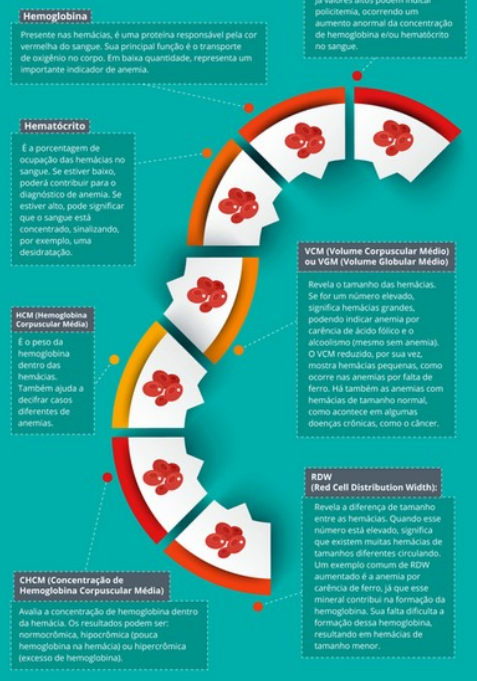
Idade	Leucócitos x 10 ⁹ /L	Neutrófilos x 10 ⁹ /L	Linfócitos x 10 ⁹ /L	Monócitos x 10 ⁹ /L	Eosinófilos x 10 ⁹ /L	Basófilos x 10 ⁹ /L	Plaquetas x 10 ⁹ /L
Nascimento	18,0 (10,0 - 26,0)	4,0 - 14,0	3,0 - 8,0	0,5 - 2,0	0,1 - 1,0	0,02 - 0,1	150 - 450
3 dias de vida	15,0 (7,0 - 22,0)	3,0 - 5,0	2,0 - 8,0	0,5 - 1,0	0,1 - 2,0	0,02 - 0,1	210 - 500
1 mês	12,0 (5,0 - 19,0)	3,0 - 9,0	3,0 - 16,0	0,3 - 1,0	0,2 - 1,0	0,02 - 0,1	210 - 650
2 meses	10,0 (5,0 - 15,0)	1,0 - 5,0	4,0 - 10,0	0,4 - 1,2	0,1 - 1,0	0,02 - 0,1	210 - 650
3 - 6 meses	12,0 (6,0 - 18,0)	1,0 - 6,0	4,0 - 12,0	0,2 - 1,2	0,1 - 1,0	0,02 - 0,1	200 - 550
1 ano	11,0 (6,0 - 16,0)	1,0 - 7,0	3,5 - 11,0	0,2 - 1,0	0,1 - 1,0	0,02 - 0,1	200 - 550
2 - 6 anos	10,0 (5,0 - 15,0)	1,5 - 8,0	6,0 - 9,0	0,2 - 1,0	0,1 - 1,0	0,02 - 0,1	200 - 450
6 - 12 anos	9,0 (5,0 - 13,0)	2,0 - 8,0	1,0 - 5,0	0,2 - 1,0	0,1 - 1,0	0,02 - 0,1	180 - 400
Adultos	7,0 (4,0 - 10,0)	2,0 - 7,0	1,0 - 3,0	0,2 - 1,0	0,02 - 0,5	0,02 - 0,1	150 - 400

Valores hematológicos de referência em adultos

		Homens	Mulheres
Hemácias	x 10 ¹² /L	5,00 - 0,5	4,3 - 0,5
Hemoglobina	g/dL	15,0 - 2,0	13,5 - 1,5
Hematócrito	(%)	45 - 5	41 - 5
Leucócitos	x 10 ⁹ /L	7,0 - 3,0	
VGM	fL	92 - 9	
HGM	Pg	29,5 - 2,5	
CHGM	g/dL	33 - 1,5	
RDW	CV (%)	12,8 - 1,2	
	SD (fL)	42,5 - 3,5	
Plaquetas	x 10 ⁹ /L	150 - 400	

Hemograma

Série vermelha



ANOTAÇÕES

06

CONTEÚDO COMPLETO

Hipertensão Arterial

Conceito:

PONTOS-CHAVE

Elevação persistente da pressão arterial, aumentando o esforço cardíaco.

Diagnóstico:

Medição por esfigmomanômetro (manual ou digital)

Avaliação com MAPA e HOLTER

Sintomas:

Dor de cabeça

Tontura

Náusea

Dor no peito

Tratamento:

Estilo de vida saudável

Uso de medicamentos (diuréticos, IECA, betabloqueadores)

Cuidados Odontológicos:

Medir PA em todo atendimento

Evitar estresse e dor

Monitorar uso de medicamentos que causam xerostomia e hiperplasia gengival

Categoria da pressão arterial	Sistólica mm Hg (máxima)		Diastólica mm Hg (mínima)
Normal	menor que 120	e	menor que 80
Pré-hipertensão	120 – 139	ou	80 – 89
Pressão arterial elevada Hipertensão estágio 1	140 – 159	ou	90 – 99
Pressão arterial elevada Hipertensão estágio 2	160 ou maior	ou	100 ou maior
Crise hipertensiva (emergência médica)	maior que 180	ou	maior que 110



ANOTAÇÕES

07

CONTEÚDO COMPLETO

Diabetes Mellitus

Tipos:

PONTOS-CHAVE

Tipo 1: não produz insulina (autoimune)

Tipo 2: resistência à insulina (associado à obesidade)

Gestacional: durante a gravidez

Diagnóstico:

Glicemia em jejum

Hemoglobina glicada

Glicemia capilar

Complicações:

Infarto, AVC, retinopatia, nefropatia, neuropatia, pé diabético

Tratamento:

Dieta, exercício físico, metformina, insulina

Cuidados Odontológicos:

Risco de infecções fúngicas e atraso na cicatrização

Boca seca e alterações no paladar

Controle periodontal ajuda na estabilidade glicêmica



DIABETES	TIPO 1	TIPO 2
Características	O pâncreas não consegue produzir a insulina.	O pâncreas produz a insulina, mas o organismo desenvolve resistência à ação desse hormônio.
Causas	Destruição das células β pancreáticas por rejeição do próprio organismo ou por causa desconhecida.	Predisposição genética (fator hereditário), dieta desequilibrada, obesidade, sedentarismo e hipertensão.
Prevalência	5 a 10% dos casos	90 a 95% dos casos.
Maior incidência	A partir da infância e da adolescência	A partir dos 40 anos.
Manifestação	Abrupta, com sintomas de sede excessiva, alta frequência urinária, cansaço, perda acentuada de peso e hálito adocicado	Mais lenta, na maioria das vezes assintomática, ou com sensações de fome e sede constantes e cansaço frequente.
Controle	Aplicações de insulina	Medicamentos orais ou aplicações de insulina.

ANOTAÇÕES

08

CONTEÚDO COMPLETO

Referências

- NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.